Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012105-58.2025.8.21.0010/RS

AUTOR: GREICE BUENO DA SILVA

RÉU: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SENTENÇA

Vistos etc.

GREICE BUENO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**, igualmente qualificada. A autora narrou, em sua petição inicial, ser diagnosticada com quadro de depressão maior grave e recorrente, com elevada resistência a tratamentos convencionais, e que, por indicação de seu médico assistente, necessitava de tratamento contínuo com o medicamento Cloridrato de Escetamina, comercialmente conhecido como Spravato®, de aplicação intranasal. Alegou que, apesar da expressa recomendação médica e da gravidade de seu estado de saúde, que incluía ideação suicida, a operadora de saúde ré teria se negado a fornecer a cobertura para o referido fármaco, o que motivou o ajuizamento da demanda para compeli-la, inclusive em sede de tutela de urgência, a custear integralmente o tratamento prescrito. **Ainda, pediu o benefício da gratuidade de justiça - que ora defiro**. Deu à causa o valor de R$ 178.368,00. Indexou procuração e documentos.

A análise do pedido de tutela de urgência resultou em decisão liminar que determinou à ré o fornecimento imediato do medicamento Spravato®, sob pena de multa. A ré foi devidamente citada e intimada, passando a cumprir, em um primeiro momento, a ordem judicial, autorizando as aplicações iniciais do fármaco.

No curso do processo, sobreveio fato novo de crucial importância: o desligamento voluntário do ex-companheiro da autora da empresa em que trabalhava, o qual figurava como titular do plano de saúde coletivo-empresarial ao qual a demandante estava vinculada como dependente. Tal fato resultou no cancelamento do contrato de plano de saúde em 30 de abril de 2025. A autora, ciente da situação, peticionou nos autos (Evento 59) informando a situação e a iminente necessidade de realizar a portabilidade de seu plano para uma modalidade individual, a fim de garantir a continuidade do tratamento, que já se mostrava eficaz.

Iniciou-se, a partir de então, um intenso debate processual acerca da responsabilidade da ré pela continuidade do tratamento. A demandada, em diversas manifestações, sustentou a legalidade do cancelamento do plano, argumentando que a extinção do vínculo do titular encerrava a obrigação contratual e que não seria possível a portabilidade de um plano coletivo-empresarial para um individual. A autora, por sua vez, defendeu seu direito à continuidade do tratamento, invocando a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do impasse e da notícia de interrupção do tratamento pela ré a partir de 13 de junho de 2025, este Juízo proferiu decisão (Evento 110), reconsiderando despacho anterior, para ordenar que a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL restabelecesse imediatamente o tratamento da autora, providenciando a aplicação da dose pendente, e formalizasse a portabilidade assistida para um plano compatível, sem a imposição de carências, sob pena de multa diária majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fundamentou-se a decisão no entendimento de que a rescisão contratual não pode servir de pretexto para a interrupção de tratamento médico essencial e em curso, citando expressamente a tese firmada no Tema 1.082 do STJ.

A ré, contudo, permaneceu inerte, descumprindo a nova ordem judicial. A autora, então, noticiou o descumprimento (Evento 120) e requereu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD para custear um mês de tratamento, bem como a majoração da multa. O pedido de bloqueio foi deferido (Evento 124), resultando na constrição da quantia de R$ 29.744,00, que foi posteriormente liberada à autora mediante alvará para a aquisição do medicamento e continuidade do tratamento.

Após a liberação dos valores, a ré apresentou petição (Evento 152) alegando que a autora teria utilizado a quantia bloqueada para custear tratamento diverso do deferido na liminar, qual seja, a aplicação de Cetamina Endovenosa, e não o Spravato® (Cloridrato de Escetamina intranasal). Argumentou que tal conduta configuraria desvio de finalidade, alteração unilateral do objeto da lide em violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil, e requereu a devolução integral dos valores, a impugnação da alteração do tratamento e a extinção do feito por perda de objeto.

Em resposta (Evento 154), a autora contrapôs a argumentação da ré, esclarecendo que a substância ativa do tratamento permaneceu a mesma (escetamina), tendo havido apenas uma alteração na via de administração (de intranasal para intravenosa). Justificou que tal mudança foi uma decisão médica de urgência, motivada pela grave descompensação de seu quadro clínico, com agravo da ideação suicida, decorrente diretamente da interrupção do tratamento imposta pela

conduta ilícita da ré. Anexou laudo médico detalhado (Evento 155) atestando a necessidade clínica da alteração e destacou que o tratamento intravenoso possui custo significativamente inferior ao do Spravato®. Acusou a ré de litigância de má-fé por tentar induzir o juízo a erro e inverter a responsabilidade pela crise de saúde que a própria operadora causou.

Analisando as novas informações e o laudo médico apresentado, este Juízo proferiu nova decisão (Evento 156), na qual acolheu a justificativa da autora e modificou a liminar para que a ordem de tratamento abrangesse o medicamento na forma de cetamina intravenosa, reconhecendo, inclusive, o benefício econômico para a demandada. Acolheu a prestação de contas parcial da autora, autorizou o uso de parte do valor bloqueado (R$ 9.750,00) para o custeio de 15 sessões do novo tratamento e determinou que o saldo remanescente (R$ 19.978,00) fosse devolvido à ré.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. A ré concordou com a substituição do tratamento para as 15 sessões já custeadas, mas insistiu que eventuais novas sessões deveriam ser solicitadas pela via administrativa, indicando dados bancários para a devolução do saldo. A autora, por fim, reiterou que a continuidade do tratamento deve ser discutida nestes autos até o trânsito em julgado, a fim de evitar novas barreiras burocráticas impostas pela operadora.

Relatei. Decido.

Impugnação ao valor da Causa:

A parte ré, em sua peça de contestação, apresentou impugnação ao valor atribuído à causa pela parte autora, sustentando que o montante indicado na exordial não corresponde ao proveito econômico efetivamente almejado, devendo ser fixado no valor de alçada.

Não obstante, não assiste razão à parte impugnante. A atribuição do valor da causa não é ato discricionário da parte, mas sim um requisito processual vinculado a critérios objetivos estabelecidos pela legislação processual civil. O valor da causa deve, tanto quanto possível, refletir a expressão econômica do bem da vida que se busca tutelar por meio da jurisdição. Em demandas que versam sobre obrigações de trato sucessivo, como é o caso do fornecimento contínuo de medicamentos ou tratamentos, a norma processual cogente estabelece que o valor deve corresponder à soma de doze prestações mensais.

O valor que deve ser atribuído à causa em ações de fornecimento contínuo de medicamentos ou tratamentos é, em regra, o custo da terapêutica pleiteada, ou seu custo ao longo de doze meses, caso o tratamento seja prestado periodicamente por período superior a um ano. Essa interpretação decorre do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Essa orientação é adotada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no tema 1.234, que fala em "valor do tratamento anual" para fins de fixação do valor da causa (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2024.

Assim sendo, rejeito a impugnação.

Mérito - Considerações Iniciais:

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Note-se que intimadas, ambas as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Da Relação Jurídica e da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre a autora, na qualidade de beneficiária de plano de saúde, e a ré, como operadora, é inequivocamente uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A matéria é, inclusive, objeto da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A incidência do CDC ao caso concreto resulta na aplicação de seus princípios norteadores, como a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor, a boa-fé objetiva, a transparência, o dever de informação e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Do Mérito da Pretensão Original: O Dever de Cobertura do Tratamento:

O cerne da controvérsia, em sua origem, residia na obrigação da operadora de saúde de custear o tratamento da autora com o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato®) para a patologia que a acomete (depressão maior grave e recorrente). A doença da autora possui cobertura contratual, tratando-se de patologia listada na Classificação Internacional de Doenças (CID). A recusa inicial da operadora, embora não tenha sido o foco principal do litígio subsequente, revela uma prática que o Poder Judiciário tem reiteradamente rechaçado.

A definição do tratamento mais adequado para a patologia do paciente é uma prerrogativa exclusiva do médico que o assiste, não cabendo à operadora de saúde imiscuir-se na terapêutica indicada. Se a doença tem cobertura contratual, os meios necessários para o seu tratamento, incluindo medicamentos, procedimentos e materiais, devem ser igualmente cobertos. A operadora pode estabelecer quais doenças estão por ela cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura de cada uma delas. A recusa em fornecer um medicamento prescrito por profissional habilitado, sob o argumento

de não constar no rol da ANS ou por ser de alto custo, configura prática abusiva, que coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário. Portanto, a pretensão original da autora para o custeio do tratamento é, em sua essência, legítima e amparada pelo ordenamento jurídico.

No mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINANDO A COBERTURA PELA DEMANDADA DO MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO POSTULADO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL, NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR3. EMBORA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE ESTEJAM DISPENSADAS DE FORNECER MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, EXCETO ANTINEOPLÁSICOS, NO CASO CONCRETO, É INCONTROVERSO QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO É DE USO AMBULATORIAL. 4. O MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 É AQUELE PRESCRITO PELO MÉDICO, ADQUIRIDO DIRETAMENTE NAS FARMÁCIAS E AUTOADMINISTRADO PELO PACIENTE, DIFERENTE DO CASO DOS AUTOS ONDE O MEDICAMENTO PRESCRITO SERÁ ADMINISTRADO EM AMBULATÓRIO, COM SUPERVISÃO MÉDICA. 5. O ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS É TAXATIVO, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NA LEI Nº 14.454/2022, COMO EFICÁCIA COMPROVADA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS TÉCNICOS RECONHECIDOS. 6. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SPRAVATO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, QUE JÁ TENHAM TENTADO DIVERSOS OUTROS TRATAMENTOS SEM SUCESSO. 7. CONFIGURADA HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO, SENDO DEVIDA A COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. IV. DISPOSITIVO8. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50058092520238211001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025)

Recente legislação alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

A Lei Federal 14.454, de 21.09.2022, em seu artigo 10, § 13, refere que:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Os precedentes jurisprudenciais também tem sido no sentido de acolher a obrigatoriedade da cobertura do tratamento buscado pela parte autora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. USO AMBULATORIAL. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina), prescrito para tratamento ambulatorial de transtorno depressivo grave, embora não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão de origem fundamentou-se no direito à saúde, consagrado constitucionalmente, e na excepcionalidade do caso clínico, com riscos à vida da paciente. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste no rol da ANS. III. Razões de decidir O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe a proteção da dignidade humana e a garantia do acesso a tratamentos necessários para a preservação da vida. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Lei nº 9.656/1998 e Lei nº 14.454/2022) reconhecem o rol da ANS como referência mínima, admitindo cobertura de procedimentos fora desse rol em hipóteses excepcionais, como a ausência de substituto terapêutico eficaz e prescrição médica justificada. O medicamento Spravato®, sendo de uso ambulatorial e essencial ao tratamento da autora, caracteriza-se como obrigação de cobertura pelo plano, uma vez que atende às exigências de excepcionalidade e eficácia. IV. Dispositivo Apelo desprovido. Unânime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929-SP; AgInt no AREsp 1198799/SP.(Apelação Cível, Nº 51066481720248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE ESCETAMINA SPRAY NASAL (SPRAVATO). ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO EM AMBIENTE HOSPITALAR. LAUDO MÉDICO QUE APONTA A NECESSIDADE DO

TRATAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51372573520248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 31-07-2024)

Da Rescisão Contratual e a Imperatividade da Continuidade do Tratamento (Tema 1.082 do STJ):

O ponto nevrálgico que dominou o trâmite processual foi a rescisão do contrato de plano de saúde em virtude do desligamento do titular do plano coletivo e a subsequente interrupção do tratamento da autora pela ré. A demandada defendeu a legalidade de sua conduta, sustentando que o fim do vínculo empregatício do titular extinguiu a obrigação contratual para com a dependente.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da legislação e, principalmente, da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A situação dos autos atrai a aplicação direta e vinculante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do **Tema Repetitivo nº 1.082**, que pacificou o entendimento sobre a matéria. Conforme restou consignado na decisão do Evento 110, a jurisprudência pátria reconhece a abusividade da rescisão contratual durante tratamento médico, mesmo nos contratos coletivos. **O STJ estabeleceu que a operadora de plano de saúde não pode interromper o tratamento de um beneficiário que esteja em meio a um procedimento médico essencial, <u>ainda que o contrato coletivo seja rescindido</u>.**

Leia-se:

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, a jurisprudência pátria reconhece a abusividade da rescisão contratual durante tratamento médico, mesmo nos contratos coletivos: "A extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade." (STJ – AgInt no AREsp 2059782/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/06/2022) "Usuário em tratamento médico. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082)." (TJSP – Apelação Cível 1002778-89.2022.8.26.0248, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 31/01/2024)

A *ratio decidendi* desse entendimento repousa nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A vida e a saúde são bens jurídicos de magnitude superior a qualquer interesse puramente contratual ou econômico. A interrupção abrupta de um tratamento médico, especialmente de natureza psiquiátrica grave como o da autora, pode acarretar danos irreversíveis e até mesmo fatais, o que torna a conduta da operadora manifestamente ilícita e abusiva. **A obrigação de continuidade do tratamento não é uma mera faculdade, mas um dever imposto pela ordem jurídica, que se sobrepõe à literalidade de cláusulas contratuais que prevejam o cancelamento automático.**

Ademais, a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, incisos I e II, estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência e emergência, o que reforça o dever de não interrupção de tratamentos essenciais à manutenção da vida. As Resoluções Normativas da ANS, como a RN nº 465/2021 e suas antecessoras, também caminham no mesmo sentido, assegurando a continuidade da assistência até a alta médica do paciente.

Portanto, a conduta da UNIMED NACIONAL ao interromper o fornecimento do medicamento à autora, após a rescisão do contrato coletivo, foi flagrantemente ilegal e abusiva, configurando um ato ilícito que violou o direito fundamental da autora à saúde e à vida, bem como o princípio da continuidade do tratamento.

Da Modificação do Tratamento e da Inexistência de Desvio de Finalidade:

A ré, em sua manifestação no Evento 152, tenta inverter a lógica dos fatos, acusando a autora de desviar a finalidade do valor bloqueado judicialmente. Essa tese é manifestamente improcedente. **A alteração da via de administração do medicamento (de intranasal para intravenosa) não foi uma escolha arbitrária da autora, mas uma consequência direta e necessária do ato ilícito praticado pela própria ré.**

Ao interromper o tratamento de forma abrupta e ilegal, a UNIMED NACIONAL provocou uma grave descompensação no quadro clínico da autora, conforme atestado no laudo médico do Evento 155. A paciente, que vinha respondendo bem à terapia, viu-se subitamente privada do único medicamento eficaz para seu quadro, o que resultou na agudização dos sintomas depressivos e no retorno da ideação suicida. Diante dessa emergência médica, a equipe assistente, em uma decisão técnica e responsável, optou pela via intravenosa da cetamina, conhecida por sua ação mais rápida e eficaz em situações de crise aguda.

Não houve, portanto, "alteração do objeto da demanda", como alega a ré. O objeto da demanda sempre foi a garantia da continuidade do tratamento para a depressão maior refratária com a substância escetamina/cetamina. A forma de administração é um detalhe técnico da execução do tratamento, cuja definição compete ao médico. A conduta da autora, ao utilizar os recursos bloqueados para dar seguimento ao tratamento na forma clinicamente indicada para a situação de crise, foi uma medida de autotutela de sua própria vida, em plena conformidade com a finalidade da decisão judicial, que era, em última análise, preservar sua saúde e integridade.

Some-se a isso o fato, incontroverso, de que o tratamento intravenoso se revelou substancialmente menos oneroso para a operadora, o que desconstitui qualquer argumento de prejuízo ou enriquecimento sem causa. A autora agiu com boa-fé, diligência e em estrita observância à prescrição médica, buscando efetivar o comando judicial da forma mais rápida e segura possível, diante da omissão recalcitrante da ré. Acolher a tese da demandada seria premiar a inércia e a ilicitude, punindo a vítima que buscou, por meios legítimos, sobreviver à crise causada pela própria operadora.

Da Obrigação de Fazer Definitiva e da Litigância de Má-Fé:

Diante de todo o exposto, a procedência do pedido é medida que se impõe. A tutela de urgência anteriormente deferida e posteriormente modificada deve ser convertida em definitiva, para condenar a ré a custear, de forma integral e contínua, o tratamento da autora com cetamina intravenosa, ou outro que venha a ser prescrito pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica.

A alegação da ré de que futuros pedidos de continuidade devem ser submetidos à via administrativa não pode prosperar. O histórico de descumprimento de ordens judiciais e a postura obstrutiva da operadora ao longo de todo o processo demonstram que a remessa da paciente a um novo ciclo burocrático representaria um risco inaceitável de novas interrupções. A jurisdição, uma vez provocada, deve assegurar a efetividade de suas decisões. Assim, a continuidade do tratamento objeto desta lide deverá ser garantida no âmbito deste processo até seu cumprimento integral.

Por fim, a conduta processual da UNIMED NACIONAL caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. **A ré opôs resistência injustificada ao andamento do processo, descumpriu reiteradamente decisões judiciais, o que exigiu a adoção de medidas coercitivas drásticas, e procedeu de modo temerário ao tentar distorcer a realidade dos fatos, acusando a autora de desvio de finalidade por uma situação que a própria operadora criou com sua conduta ilícita.** Tal comportamento atenta contra a dignidade da justiça e causa prejuízos evidentes à parte contrária, devendo ser coibido com a aplicação da respectiva penalidade.

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **GREICE BUENO DA SILVA** em face de **UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL**, para: **a) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA** concedida e modificada nos autos (Evento 158), para **CONDENAR** a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, o tratamento da autora com o medicamento **cetamina por via intravenosa** (ou outro que venha a ser prescrito pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica), incluindo o fármaco, materiais, honorários médicos e despesas hospitalares/ambulatoriais, na periodicidade e dosagem indicadas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de manutenção da multa diária já fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua majoração ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente; **b) DECLARAR** a regularidade do uso da quantia de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais), oriunda do bloqueio judicial, para o custeio das 15 (quinze) sessões iniciais do tratamento, determinando a expedição de alvará em favor da ré para levantamento do saldo remanescente de R$ 19.978,00 (dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais), devidamente corrigido, conforme dados bancários indicados no Evento 163 e em conformidade com a decisão do evento 156, DOC1; **c) CONDENAR** a ré, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil; **d) CONDENAR** a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Caxias do Sul,16 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIO VIEZZER, Juiz de Direito**, em 16/09/2025, às 18:03:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090444558v28** e o código CRC **890a058b**.